

AAMIA · RESUMEN TEMÁTICO 2 DE 5

Autonomía, cuidados cotidianos y entorno seguro

Rutinas, higiene, piel, sueño, caídas, trato digno y apoyo al cuidador

autonomía

actividades diarias

higiene

Audiencia: Personas mayores, familias y cuidadores domiciliarios

Uso responsable

Este documento organiza y resume una biblioteca local. No diagnostica, no prescribe y no sustituye una valoración profesional. Las fuentes originales son la evidencia canónica; las referencias usan la página física del PDF.

Edición 1.0 · Julio de 2026 · Proyecto AAMIA

Cómo usar este resumen

Está diseñado para recuperación aumentada: cada apartado concentra una intención de búsqueda y conserva referencias legibles. Para decisiones importantes se consulta la fuente original y al equipo profesional.

Campo	Valor
Tema principal	Autonomía, cuidados cotidianos y entorno seguro
Temas de recuperación	autonomía, actividades diarias, higiene, piel, sueño, caídas, maltrato, cuidador
Tipo de fuente	Resumen secundario; remite a evidencia original
Riesgo clínico	Mixto: educativo con señales de consulta y urgencia
Contexto Markdown	Usado para redactar; no es documento indexado

Principios de síntesis

- Ayudar solo en lo necesario conserva capacidad, identidad y dignidad.
- Una rutina predecible debe ser flexible y construirse con la persona.
- El entorno puede aumentar o reducir discapacidad; seguridad y autonomía deben diseñarse juntas.
- Cuidar bien requiere relevo, capacitación y atención a la salud de quien cuida.

Jerarquía de uso

- 1) localizar el tema; 2) recuperar los fragmentos originales; 3) responder indicando documento y página;
- 4) reconocer cuando la biblioteca no basta.

1. Cuidado centrado en la persona

El cuidado cotidiano comienza pidiendo permiso, explicando cada paso y respetando preferencias, tiempos y privacidad.

- Preguntar cómo desea ser llamada, qué actividades quiere conservar y dónde necesita apoyo.
- Ofrecer opciones reales en ropa, horarios, alimentos, actividades y organización del día.
- Evitar infantilizar, apresurar, regañar o hablar como si la persona no estuviera presente.
- Revisar si el apoyo sigue siendo proporcional: demasiada ayuda puede reducir función y autoestima.

Principios en [R1, pp. 2-3], [R2, p. 11], [R3, pp. 5 y 28] y [R5, p. 16].

2. Rutina que permite observar cambios

Combinar autocuidado, alimentación, movimiento, descanso y contacto social facilita el día y revela cambios respecto de lo habitual.

- Al iniciar, observar orientación, ánimo, dolor, respiración y capacidad para levantarse.
- Preparar objetos en orden de uso y dar tiempo suficiente para aseo, vestido y baño.
- Alternar actividad y descanso y mantener al alcance agua y apoyos permitidos.
- Registrar alimentación, líquidos, evacuaciones, actividad, sueño, dolor, caídas y novedades.

Rutina sintetizada de [R1, p. 3], [R2, pp. 121 y 124] y [R3, pp. 5 y 65].

3. Higiene, boca y piel

La higiene protege salud, imagen personal y autoestima. Debe realizarse con privacidad y participación.

- Adaptar baño, manos, boca, cabello, uñas y ropa al grado de independencia.
- Mantener prótesis dentales limpias y revisar ajuste, dolor, heridas, boca seca o dificultad para masticar.
- Observar piel expuesta a presión o humedad. Enrojecimiento persistente, herida, dolor, secreción u olor requieren valoración.
- En movilidad muy limitada, solicitar un plan profesional de posición, superficies de apoyo, nutrición y continencia.

Higiene y piel: [R2, pp. 26, 128 y 136-137], [R3, pp. 24 y 28], [R5, p. 29] y [R13, p. 25].

4. Sueño y descanso

El sueño puede cambiar con la edad, pero insomnio persistente, somnolencia excesiva o pausas respiratorias observadas merecen consulta.

- Mantener horarios regulares, luz diurna, actividad apropiada y una rutina tranquila al final del día.
- Reducir ruido, luz intensa y pantallas; preparar una ruta nocturna iluminada al baño.
- Revisar dolor, necesidad de orinar, ansiedad, estimulantes y posibles efectos de medicamentos.
- No iniciar sedantes o productos para dormir por cuenta propia; pueden aumentar confusión y caídas.

Apoyo en [R1, p. 3], [R2, p. 121] y [R6, pp. 59-62].

5. Hogar seguro y respuesta a caídas

La revisión del entorno sigue las rutas usadas de día y de noche. Después de una caída se valora seguridad antes de mover.

- Retirar cables, tapetes y obstáculos; mejorar iluminación y contraste.
- Instalar apoyos firmes y superficies antideslizantes cuando sean necesarios.
- Revisar calzado, lentes, audición, bastón o andadera; las caídas suelen tener varias causas.
- No levantar de inmediato ante golpe en cabeza, dolor intenso, deformidad, sangrado, pérdida de conciencia o incapacidad para moverse.
- Registrar circunstancias y avisar al equipo de salud si la caída es nueva o repetida.

Prevención y respuesta en [R1, p. 6], [R2, pp. 94 y 121], [R5, p. 16] y [R6, pp. 65-66].

6. Calidad del cuidado y prevención del maltrato

El maltrato puede ser físico, psicológico, sexual, económico, por negligencia o por restricción injustificada.

- Observar lesiones sin explicación, miedo, higiene deficiente, sobremedicación, aislamiento, cambios conductuales o control indebido del dinero.
- Escuchar en privado cuando sea seguro y no confrontar si aumenta el riesgo.
- Ante peligro inmediato, contactar emergencias o servicios locales de protección.
- Capacitación, supervisión, personal suficiente y vías de queja forman parte de la calidad institucional.

Calidad en [R7, pp. 4 y 8]; dependencia en [R8, pp. 5-6]; maltrato en [R9, pp. 4-6] y [R6, pp. 31-33].

7. Cuidar a quien cuida

El agotamiento indica que la carga supera recursos disponibles; no es una falla moral.

- Distribuir tareas, horarios y contactos; acordar relevos antes de una crisis.
- Conservar sueño, alimentación, movimiento, atención médica y vínculos propios.
- Buscar apoyo ante irritabilidad persistente, aislamiento, desesperanza o sensación de no poder continuar.
- Si aparecen ideas de hacerse daño o dañar a la persona cuidada, pedir ayuda urgente y crear distancia segura.

Sobrecarga y red de apoyo en [R3, pp. 60-65], [R4, p. 14] y [R14, pp. 1, 3 y 5].

Orientación por nivel de acción

Esta tabla no es un sistema de triaje. Resume una respuesta conservadora a cambios comunes y señales de peligro.

Nivel	Situación	Acción
Adaptar	La actividad es lenta o requiere ayuda parcial.	Dar tiempo, simplificar pasos y ofrecer apoyos estables.
Consultar	Caídas repetidas, insomnio persistente, lesión de piel, pérdida funcional o agotamiento.	Solicitar valoración con un registro de frecuencia y contexto.
Proteger	Lesión grave, pérdida de conciencia, sospecha de abuso o riesgo inmediato.	Contactar emergencias o protección y no dejar sola a la persona en riesgo.

Regla de seguridad

Cuando el cambio es súbito, intenso, empeora rápido o la persona no puede mantenerse a salvo, se prioriza ayuda humana inmediata sobre la consulta al RAG.

Qué debe conservar una respuesta de AAMIA

- Diferenciar educación general de indicaciones personalizadas.
- Mostrar fuentes originales y páginas que sostienen la respuesta.
- Declarar incertidumbre, antigüedad o desacuerdo entre fuentes.
- No transformar procedimientos clínicos en instrucciones domésticas.
- Recordar que autonomía, preferencias y contexto importan.

Fuentes utilizadas

Las páginas son páginas físicas del PDF. Las referencias documentan conceptos centrales; no implican adoptar toda afirmación de la fuente.

Criterio editorial

Se priorizaron recomendaciones convergentes, prudentes y aplicables. Las fuentes antiguas o especializadas se conservaron como contexto cuando requerían corroboración actual.

[R1] AAMIA_guia_abierta_para_el_cuidado.pdf

Páginas PDF: 2-3, 6-7. Tipo: Guía abierta.

[R2] MANUAL_BASICO_CUIDADO_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES_16_JULIO_221021.pdf

Páginas PDF: 11, 26, 94, 121, 124, 128, 136-137, 160. Tipo: Manual institucional.

[R3] Manual_de_Apoyo_con_el_Cuidado_de_PAMS.pdf

Páginas PDF: 5, 24, 28, 56, 59-65. Tipo: Manual institucional.

[R4] Guía de cuidados básicos interactivo.pdf

Páginas PDF: 14, 43, 62. Tipo: Guía práctica.

[R5] Manual_cuidados-generales.pdf

Páginas PDF: 16, 19, 29. Tipo: Manual práctico.

[R6] Cuidado de los adultos mayores (Lesur, Luis).pdf

Páginas PDF: 31-33, 51, 59-66, 255. Tipo: Libro de consulta.

[R7] Calidad_del_cuidado_del_adulto_mayor_en.pdf

Páginas PDF: 4, 8. Tipo: Artículo de investigación, 2005.

[R8] Dejar de ser o hacer - significado de dependencia funcional para el adulto mayor.pdf

Páginas PDF: 5-6. Tipo: Artículo cualitativo.

[R9] Maltrato-en-el-adulto-mayor-institucionalizado--_2012_Revista-M-dica-CI-nica.pdf

Páginas PDF: 4-6. Tipo: Revisión, 2012.

[R10] Experiencia-ci-nica-de-la-fundaci-n-villa-de-anci_2012_Revista-M-dica-CI-nic.pdf

Páginas PDF: 1-5. Tipo: Experiencia institucional, 2012.

[R11] Espacio-sociosanitario-del-adulto-mayor--miradas_2012_Revista-M-dica-CI-nica.pdf

Páginas PDF: 1-5. Tipo: Salud pública, 2012.

[R12] Envejecer con alegría guía para acompañar y vivir la tercera edad (Montoya Carrasquilla, Jorge).pdf

Páginas PDF: 17, 64, 75. Tipo: Libro de consulta.

[R13] Manual de práctica cuidado del adulto y el envejeciente (Sepúlveda Estévez, Magdalena).pdf

Páginas PDF: 25. Tipo: Manual académico.

[R14] Hijos-adultos-mayores-al-cuidado-de-sus-padres--_2012_Revista-M-dica-CI-nica.pdf

Páginas PDF: 1, 3, 5. Tipo: Artículo psicosocial, 2012.

Contexto editorial no indexado

Estos Markdown ayudaron a contrastar lenguaje y necesidades domésticas. No se incorporan al índice ni a la carga pública.

- Artículo web- Cuidado de adultos mayores en casa- Una guía integral.md (adaptación y apoyo domiciliario; no indexado).
- Artículo web- Qué cuidados debo brindar a un adulto mayor.md (higiene, entorno y participación; no indexado).
- Transcripción video de YouTube - Cuidado básico del adulto mayor webinar.md (autonomía, sueño y roles; no indexado).